

Reflujo gastroesofágico (RGE) y enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

1. Introducción y relevancia clínica

El **reflujo gastroesofágico (RGE)** se define como el **paso retrógrado del contenido gástrico al esófago**, que puede o no llegar a la boca.

En los **lactantes**, es un fenómeno **fisiológico y frecuente**, debido a la inmadurez del esfínter esofágico inferior (EEI) y a la alimentación líquida en decúbito.

Cuando el reflujo se asocia a **síntomas o complicaciones** (vómitos persistentes, esofagitis, falla de crecimiento o síntomas respiratorios), se denomina **enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)**.

En Chile, según las guías del **MINSAL y la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIFE)**, el enfoque del RGE debe priorizar **medidas posturales y dietéticas** antes de iniciar fármacos, reservando el tratamiento médico o derivación para casos de **ERGE confirmada o complicada**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo fisiológico

El **EEI** normalmente previene el reflujo mediante:

- Tono basal adecuado.
- Presión abdominal mayor que la torácica.
- Peristaltismo esofágico que limpia el reflujo ácido.

En los lactantes, la **inmadurez del EEI** permite episodios transitorios de relajación que causan regurgitaciones.

b. Factores predisponentes

- Posición horizontal postprandial.
- Alimentación líquida en grandes volúmenes.

- Hipotonía del EEI.
- Hernia hiatal.
- Prematurez.
- Aumento de presión intraabdominal (tos, constipación, distensión).

c. Evolución natural

- Pico de regurgitaciones a los **4 meses**.
- Disminuye progresivamente hacia los **12–18 meses**.
- En la mayoría, es **autolimitado** y no requiere tratamiento.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

RGE fisiológico (no patológico)

- Lactante sano, con crecimiento adecuado.
- Regurgitación postprandial de pequeño volumen (“babeo” o “vomitito feliz”).
- Sin signos de malestar, sin alteraciones respiratorias.
- Sin complicaciones (esofagitis, apnea, anemia).

No requiere estudios ni fármacos.

b.

ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico)

Síntomas o signos **patológicos o complicaciones** del reflujo.

Digestivos:

- Vómitos persistentes o de gran volumen.
- Irritabilidad, llanto inconsolable.
- Rechazo alimentario.
- Falla de crecimiento.
- Hematemesis o anemia por esofagitis erosiva.

Respiratorios o atípicos:

- Tos crónica, disfonía.
- Laringitis o sibilancias recurrentes.
- Apneas, broncoespasmo, neumonía aspirativa.

c. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencia clave
Estenosis hipertrófica de píloro	Vómitos en proyectil, alcalosis, masa epigástrica.
Alergia a proteína de leche de vaca (APLV)	Diarrea, sangre en heces, dermatitis.
Infección urinaria	Fiebre y vómitos sin relación alimentaria.
Obstrucción intestinal	Distensión abdominal, vómitos biliosos.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

En la mayoría de los casos de **RGE fisiológico**, el **diagnóstico es clínico** y **no se requieren exámenes**.

a. Indicaciones de estudio

- Falla de crecimiento o sospecha de ERGE.
- Síntomas respiratorios o complicaciones digestivas.
- Hematemesis, anemia, disfagia.

b. Exámenes disponibles

Examen	Utilidad
pH-metría esofágica 24 h	Gold standard: mide exposición ácida esofágica.
Impedanciometría multicanal (pH + no ácido)	Detección de reflujo no ácido; útil en pacientes con inhibidores de bomba de protones (IBP).
Endoscopía digestiva alta con biopsia	Diagnóstico de esofagitis, úlceras, estenosis o EoE.
Tránsito esófago-gástrico	Evalúa anatomía y descarta obstrucción, pero no confirma ERGE.
Ecografía abdominal	Descarta estenosis de píloro en vómitos persistentes.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIFE / ESPGHAN 2023)

El manejo depende de la **gravedad y repercusión clínica**.

a.

Medidas generales y posturales

(primera línea)

Indicadas en **todo lactante con RGE fisiológico o leve**:

1. **Fraccionar la alimentación** (menores volúmenes, más frecuentes).
2. **Evitar posición horizontal inmediata** tras comer; mantener **posición semisentada 30 min.**
3. **Evitar presión abdominal** (ropa ajustada, pañales apretados).
4. **Elevar cabecera de la cuna 30°** (solo bajo supervisión).
5. **Continuar lactancia materna exclusiva**; si fórmula, usar **espesadas** (con almidón o goma).

☐ Estas medidas son suficientes en >80 % de los casos.

b.

Fórmulas especiales

- **Leches anti-reflujo (AR)**: con espesantes naturales (almidón de maíz o arroz).
 - **Si sospecha de APLV asociada**: fórmulas extensamente hidrolizadas o aminoacídicas por 2–4 semanas de prueba diagnóstica.
-

c.

Tratamiento farmacológico (solo ERGE confirmada o complicada)

Debe reservarse para casos con esofagitis demostrada, compromiso nutricional o síntomas persistentes pese a medidas no farmacológicas.

Fármaco	Dosis pediátrica	Comentarios
---------	------------------	-------------

Inhibidores de bomba de protones (IBP) (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol)	Omeprazol 1 mg/kg/día (máx. 20 mg)	Elección principal en esofagitis. Usar 4–8 semanas.
Antagonistas H₂ (ranitidina, famotidina)	Ranitidina 2 mg/kg/dosis cada 12 h (ya en desuso)	Menor eficacia y taquifilaxia.
Procinéticos (domperidona, metoclopramida)	No recomendados	Riesgo extrapiramidal, sin beneficio demostrado.

El uso de IBP debe **reevaluarse cada 8 semanas y no mantenerse indefinidamente.**

d.

Tratamiento quirúrgico

Solo en casos de **ERGE grave, refractaria o con complicaciones severas**, como:

- Aspiración pulmonar recurrente.
- Hernia hiatal grande.
- Retraso del vaciamiento gástrico severo.

Técnica: funduplicatura de Nissen (por vía laparoscópica).

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones de la ERGE no tratada

- Esofagitis erosiva o ulcerada.
- Estenosis esofágica.
- Anemia por sangrado crónico.

- **Broncoaspiración o neumonía recurrente.**
- **Laringoespasmo o apnea obstructiva.**

b. Pronóstico

En la mayoría de los lactantes, el RGE fisiológico desaparece antes de los **18–24 meses**. La ERGE bien manejada tiene pronóstico excelente con resolución completa.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **Regurgitación sin compromiso del crecimiento = reflujo fisiológico.**
2. El **diagnóstico de ERGE es clínico**, apoyado por estudios solo si hay complicaciones.
3. **Medidas posturales y alimentarias** son el tratamiento inicial.
4. **No iniciar IBP ni fórmulas especiales sin indicación clara.**
5. En **sospecha de APLV**, usar fórmula hidrolizada antes de IBP.
6. **Endoscopia** solo si hematemesis, disfagia o síntomas persistentes.
7. La mayoría de los casos **resuelven espontáneamente** hacia el segundo año.

☐ **Errores frecuentes:**

- Diagnosticar “ERGE” en todo lactante que vomita.
 - Usar omeprazol sin confirmación ni tiempo definido.
 - Indicar metoclopramida o domperidona (efectos adversos).
 - Suspender lactancia innecesariamente.
 - Interpretar tránsito baritado como confirmatorio de ERGE.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **reflujo gastroesofágico (RGE)** es fisiológico en la mayoría de los lactantes y **autolimitado**.
2. Se considera **enfermedad (ERGE)** cuando hay **síntomas o complicaciones** (falla de crecimiento, esofagitis, síntomas respiratorios).
3. El manejo inicial es **postural y dietético**: pequeñas tomas, posición semisentada, fórmulas espesadas.
4. **IBP (omeprazol 1 mg/kg/día)** solo en ERGE confirmada o con esofagitis.
5. **No usar procinéticos ni H₂** de forma rutinaria.
6. **No suspender lactancia materna.**
7. Pronóstico excelente; resolución antes de los 2 años en la mayoría.